جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : نجاة سعيد عبد الخالق غراب
المحافظة : المنوفيه **الحي / المدينة :** شبين الكوم **العنوان :** =
رقم البطاقة : 26703171701243 **رقم التليفون :** 01221977221 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 17-03-1967 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجاة سعيد عبد الخالق غراب
National ID: 26703171701243

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

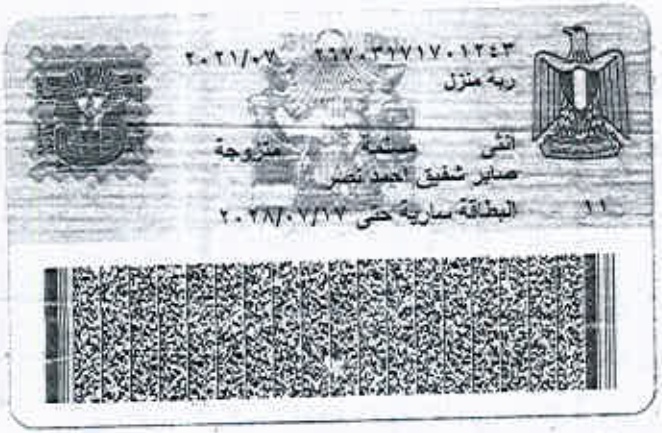
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





نرويا

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Dar El-Salam Caner Center

Radiology Department

مركز أورام دار السلام

قسم الأشعة

Name: nagat saeed abdelkhalek
Date: 8 April 2021

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *average in size (about 14 cm at the right MCL), smooth outline, bright echopattern.*
  No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- *Portal vein is not dilated and patent .*

Gall Bladder: -

- *Average size , , normal wall thickness, no stones..*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

- *Average size (About 10 cm), displaying homogenous echopattern.*

Kidneys: -

Are of normal size , site , well differentiated , bilateral renal gravels seen , no backpressure changes, no solid or cystic lesion.
-Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion
No ascites.

Urinary Bladder: -

- *Average capacity with no stones, masses or diverticular qut pouching*

Uterus & Both ovaries : *no abnormality.*

Opinion:

- ***Bright liver.*** **(fatty).**
- ***Bilateral renal gravels.***

Best regards
Dr: Doaa Ahmed . FEBR, MD

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

Name: نجاه سعيد عبد الخالق عراب	
MR. : 4999	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 58-year-old individual with a history of right-sided breast cancer treated with right breast conserving surgery (CBS) and axillary lymph node dissection (ALND) performed in May 2020, pathology revealing pT2 N3 disease. Staging at that time was M0 by CT scan. Hormone receptor testing showed estrogen receptor (ER) 7/8 positive, progesterone receptor (PR) 6/8 positive, HER2 negative, and Ki-67 0%. Adjuvant therapy included four cycles of AC (doxorubicin and cyclophosphamide) followed by four cycles of taxane (TXT), postoperative radiation therapy (PORT), and adjuvant aromatase inhibitor (AI) therapy. Since 2021 the patient has been receiving zoledronic acid (ZOMETA). The most recent bone scan in June 2026 demonstrated no evidence of disease (FREE). The patient is currently on femara (letrozole) with supportive treatment as planned.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر

يعتمد ,

Patient name: Nagat Saeed

Date: 11-4-2022

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Clinical Background:

- Status post-right BCS, for follow up

Report:

- Scattered fibroglandular densities of the left breast (ACR B)
- The right breast shows regression of the magnitude of the forenoted post-operative/therapy changes are seen evidenced by:
  - UOQ scarring .
  - Diffuse skin thickening.
  - [illegible] breast parenchyma along with mild interstitial edema.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Ngah Saeed Abdel Khalek Ghorab	Date : 03/05/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 1378/2020	Pat. ID: 33161

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had CBS in

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are almost entirely fatty (ACR A)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Pathology Report

Name: نجلاء سعيد عبد الخالق Age: 52 years.

Clinical data: Right breast cancer.

Specimen type: Wide local excision & axillary clearance.

Date: 30 /5/2020

Lab. Number: 720 Hospital Number: 1378/2020

Gross Description:

Sector of breast tissue; 11x6.5x5 cm, with partial skin covering; 8x4 cm and with attached axillary tissue; 10x7x3 cm, received enblock. Serial cuts revealed an ill-defined gritty greyish white mass; 3.5x3 cm, located; 1.5 cm deep to skin and located (1.8 & 1.2) cm from (lateral, medial superior, inferior & deep) margins respectively. Axillary dissection revealed 18 nodules, up to; 2.8x2 cm.

Microscopic Examination & Diagnosis:

Right breast wide local excision & axillary clearance;

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m3130

Female

13/05/2020 09:13

01/07/2020 09:30

Primary Sample

Left Breast

Test

ER & PR & HER2 neu & Ki67 [ER&PR : Allred scoring system -Her2neu : DAKO scoring system]

Comment

Technique

Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody. - CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (1E2)Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by : -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAKO Autostainer on ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by :- CONFIRM anti K-67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result

ER :moderate nuclear staining of >60 % of tumour cells
PR :moderate nuclear staining of 30 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression :NO membrane staining of tumor cells
Ki-67 :NO nuclear staining of tumour cells

Referral Lab

Comment

Conclusion

ER POSITIVE (SCORE 7/8)
PR POSITIVE (SCORE 6/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE
Ki67 THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ZERO

Pathologist

P. Box [illegible] Street, Amman, Jordan
Tel: 06-5520729
www.moh.gov.jo

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]